

11 - 06- Tumeurs des parties molles des membres - Pr El Haoury

(0:00 - 0:39)

Chers étudiants, aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre des tumeurs de pathologie de la pareille locomoteur en parlant des tumeurs des parties molles des membres. En commençant par notre cas clinique, il s'agit d'une patiente âgée de 40 ans qui présente depuis un an une tumefaction du quatrième doigt droit, apparue de toute petite taille et qui augmente progressivement de volume. Et depuis qu'elle est devenue douloureuse et gênant le travail, la patiente vient consulter.

(0:41 - 1:41)

Alors quels sont les objectifs de ce cours ? Bien sûr, il faut définir les différents tumeurs des parties molles, c'est comme pour les tumeurs osseuses, déterminer les bases de la classification anatomopathologique des tumeurs des parties molles, préciser la démarche du diagnostic de ces tumeurs, décrire les principes thérapeutiques. Les tumeurs des parties molles, c'est l'ensemble de tumeurs bénignes ou malignes développées au dépens du tissu conjonctif commun extrasquelettique et de ces variétés spécialisées, notamment le tissu adipeux, le tissu fibreux, les vaisseaux, les nerfs périphériques, les muscles striés ou lisses, la peau. Et bien sûr, parmi ces tumeurs, on distingue les tumeurs bénignes les plus fréquentes et les tumeurs malignes qui représentent moins de 1% de tous les cancers de l'adulte.

(1:42 - 2:01)

Elles se voient à tout âge, sans prédominance de sexe. Leur variabilité morphologique rend que ces tumeurs représentent un véritable défi diagnostique. Celui-ci repose sur la clinique, l'imagerie et l'histologie, qui représentent la clé de voûte du diagnostic.

(2:02 - 2:42)

Une prise en charge optimale du patient passe par une bonne collaboration entre pathologiste, chirurgien, radiologue, oncologue et radiothérapeute, d'où la multidisciplinarité joue un rôle important dans ce type de tumeurs. Comme pour les tumeurs osseuses, les tumeurs de tissu mou se développent en fonction du tissu d'origine, selon la classification de l'OMS. Le tissu d'origine peut être un tissu conjonctif, tissu graisseux, musculaire, vasculaire, synovial, etc.

(2:44 - 3:55)

Et donc, on va avoir différents types de tumeurs, notamment pour les tumeurs bénignes, les tumeurs les plus fréquemment rencontrés, notamment les lipomes, les tumeurs assez logeantes, surtout au niveau de la main, ensuite les fibromes, etc. Concernant les tumeurs malignes, alors nous avons les sarcomes de bas degré de malignité, notamment les tumeurs du tissu graisseux,

les liposarcomes, voire les tumeurs du tissu fibro, les isthiocytofibromes, alors que pour les tumeurs de haut degré de malignité, ce sont les tumeurs du tissu synovial, notamment les synoviosarcomes. L'examen clinique va commencer par un interrogatoire, à la recherche du début de l'apparition de la tumefaction, tel est le cas de notre patiente qui rapporte un délai d'un an d'évolution, donc c'est une tumeur qui avait la taille de lentille et qui a augmenté de volume progressivement jusqu'à ce qu'elle est devenue douloureuse.

(3:56 - 4:18)

Donc ce sont en général des tumeurs qui apparaissent de petite taille et qui ne sont pas douloureuses et qui augmentent progressivement de volume. Cela ne veut pas dire qu'une tumeur qui augmente de volume dans le temps est une tumeur bénigne ou il y a certains signes de malignité. Donc le diagnostic, il sera confirmé par l'histologie.

(4:19 - 4:52)

Donc on va voir l'augmentation rapide ou progressive de la tumeur, donc le plus souvent l'augmentation rapide est en faveur de la malignité, mais la confirmation sera toujours histologique. La douleur, le plus souvent ce sont des tumeurs qui ne sont pas douloureuses. Elles peuvent s'accompagner de douleurs lorsqu'elle est sur le trajet d'un axe vasculaire ou nerveux ou d'une compression ou d'une élévation d'une structure nerveuse.

(4:52 - 5:33)

Là il va y avoir des douleurs. Parfois on peut avoir des douleurs du fait de la structure de la tumeur, notamment des tumeurs des gaines nerveuses qui sont très douloureuses. On cherchera aussi la notion de traumatisme qui peut simuler une pseudo-tumeur, notamment soit un hématome, soit un névrus, donc des lésions nerveuses qui passent inaperçues, qui sont très douloureuses, ou bien des fausses anévrismes qui simulent des tumeurs vasculaires.

(5:35 - 6:05)

Bien sûr, les antécédents de tumeurs, parce qu'on peut avoir aussi des tumeurs récidivantes lorsque l'exérèse n'est pas totale. Certaines tumeurs peuvent avoir d'autres localisations, notamment au niveau de la main, de l'angle. On peut avoir une localisation unique ou multiple, et l'exérèse d'une seule localisation et ne pas faire de diagnostic de l'autre va garder la douleur chez le patient.

(6:08 - 6:48)

Donc après l'interrogatoire, nous allons passer à l'examen physique, notamment l'examen local, et nous allons voir le siège de la tumefaction, est-ce qu'elle est en proximité de racines, tout en sachant que les tumeurs qui sont à proximité des racines, notamment au niveau de la racine de la cuisse, au niveau de la région scapulaire, au niveau du pli du coude ou du creux poplité, ce

sont des tumeurs qui sont suspectes de malignité. On voit s'il n'y a pas de compression vasculonerveuse. On recherchera l'état de la peau en regard.

(6:49 - 7:22)

La circulation collatérale. Le type de la tumeur, par exemple, ici on voit une tumeur qui est ulcéro-bourgeonnante au niveau de la racine de la cuisse, et qui témoigne de la malignité, donc c'est un sarcome, des parties molles. La selle de bas et à droite, on voit ici une tumeur qui est nécrotique, avec une fistule à la peau, qui témoigne aussi de la malignité.

(7:24 - 8:03)

Lorsque la tumeur est augmentée de volume, donc lorsque la taille dépasse les 5 à 6 cm, elle semble suspecte de malignité. On cherchera aussi la chaleur locale. On cherchera s'il n'y a pas de... si la tumeur n'est pas chaude, n'est pas battante ou pulsatile, soit à la palpation ou à l'auscultation, qui témoigne par exemple, comme on voit ici, une tumeur vasculaire, notamment les malformations artério-veineuses, qui donne cet aspect de lésions vasculaires multiples, qui sont difficiles à prendre en charge.

(8:06 - 8:54)

Après l'examen local, donc nous passons à l'examen loco-original et général, à la recherche de retentissement de la tumeur sur les éléments vasculonervaux en aval, notamment les signes de compression. Donc on voit ici chez cette patiente qui présente un fibrosarcome, une circulation collatérale qui est importante, mais aussi une localisation au niveau du tiers inférieur de la cuisse et du creux poplité, avec compression du nerf fibulaire commun, d'ailleurs qui a été retrouvé en peropératoire. Donc il y avait des signes de paresthésie de la face externe de la jambe et de la face dorsale du pied.

(8:55 - 9:50)

On recherchera aussi les licences d'amniotrophie, surtout en aval, parce qu'on a la tumeur qui va faire augmenter le volume de la zone intéressée, quoique ce sont des patients, lorsque la tumeur est de volume important, ce sont des patients qui n'arrivent pas à marcher en aura une amniotrophie associée. On recherchera les herbes immunitaires, surtout pour les tumeurs qui ont une composante lymphatique, surtout pour les tumeurs épidermoïdes, alors que pour les sarcomes, elles ne donnent rarement, voire pas d'adénopathie. Bien sûr, on verra le retentissement de ces tumeurs sur l'état général et voir s'il n'y a pas d'altération de l'état général.

(9:53 - 10:27)

Néanmoins, il faut faire attention que l'examen clinique lui seul ne va pas permettre de conclure entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne. Donc, il faut faire attention à certains tumeurs,

à certains aspects des tumeurs, notamment lorsqu'il s'agit de masse sous apomoneurotique, lorsqu'elle dépasse les 5 cm, c'est une tumeur suspecte. Lorsqu'il y a une absence de fixité, cela ne veut pas dire qu'elle est bénigne.

(10:28 - 10:47)

Lorsqu'une tumeur qui dure longtemps ne signifie pas qu'elle est bénigne. Il y a des tumeurs malignes qui évoluent pendant des années, voire des dizaines d'années. On peut avoir aussi une tumeur de petite taille qui peut être maligne.

(10:47 - 11:15)

Donc, attention, l'examen clinique seul ne pourra pas faire la part des choses. Donc, il faudra s'aider par des investigations complémentaires, notamment l'imagerie et l'histologie qui va poser le diagnostic. Alors, la deuxième démarche diagnostique après l'examen clinique, c'est le bilan paraclinique.

(11:17 - 11:58)

Il va comprendre une radiographie standard, plus ou moins une échographie, donc tout dépendra de l'aspect de la tumeur, une TDM, voire un enjeu scanner, et bien sûr, chacune a ses indications, et bien sûr, l'IRM qui joue un rôle très important dans le diagnostic des tumeurs des tumeurs. D'accord ? Donc, on verra autres éléments paracliniques. Concernant la radiographie standard, son apport dans les tumeurs des tumeurs n'est pas aussi important que son apport pour les tumeurs osseuses.

(11:59 - 12:42)

Et donc, pour les tumeurs, on va plutôt rechercher des calcifications, par exemple, voire des ossifications de certaines tumeurs. On va aussi voir des empreintes de la tumeur sur l'os, donc des érosions, par exemple, dans le cas des tumeurs lumineuses, qu'on verra voir par la suite, ou bien on va voir est-ce que c'est une tumeur osseuse à point de départ osseux, ou une extension d'une tumeur des parties molles vers l'os, quoique c'est difficile de faire la part des choses. Actuellement, l'échographie est devenue, comment dire, le sixième doigt du chirurgien.

(12:43 - 13:02)

Elle est incontournable pour le complément de l'examen clinique. Elle permet d'éliminer une fausse image tumorale, notamment l'excès de graisse, un muscle accessoire, une hernie musculaire, voire un faux anévrisme. Lorsqu'il s'agit d'une plaie négligée, on regarde un trajet vasculaire.

(13:04 - 13:29)

Elle va permettre, pour cela, de préciser la structure de la masse, notamment est-ce qu'elle est épistrique, est-ce qu'elle est tussulaire. Vasculaire, bien sûr, grâce au Doppler, qui va permettre d'analyser la vascularisation, ainsi que le retentissement sur les vaisseaux de voisinage. L'échographie va permettre de préciser la localisation superficielle ou profonde de la tumeur par rapport au patient.

(13:30 - 13:53)

Et bien sûr, elle permet d'orienter la biopsie. Actuellement, les biopsies écovidées sont devenues de plus en plus fréquentes pour les tumeurs des tissus. L'IRM, c'est l'imagerie incontournable dans le diagnostic des tumeurs des tissus.

(13:54 - 14:15)

Elle doit être réalisée avant toute biopsie. C'est un élément qui est très important. Elle permettra d'analyser les constituants de la tumeur, de rechercher la taille, le contour, l'extension, ainsi que les rapports par rapport au tissu avoisinant, notamment le tissu vasculonerveux, voire les muscles.

(14:15 - 14:35)

Et ça nous permettra de planifier le geste chirurgical. Lorsqu'une tumeur envahit le pédicule, la prise en charge est différente d'une tumeur où le pédicule sera juste refoulé et n'en envahit. On cherchera s'il n'y a pas de nécrose intratumorale.

(14:37 - 15:15)

L'IRM aussi permettra de réévaluer l'aspect de la tumeur après le traitement, soit par chimiothérapie ou radiothérapie, soit par chirurgie. Parmi les signes qui peuvent évoquer la malignité d'une tumeur des parties molles, notamment lorsqu'il s'agit d'un signal inhomogène en T1, voire l'absence de signal ou d'hyposignal en T2. Lorsque la taille de la tumeur dépasse les 33 mm, lorsqu'elle est de siège sous-aponeurotique et en cas de présence tumorale.

(15:16 - 15:55)

Attention, le caractère net ou imprécis des limites n'est pas corrélé à la b nignit  ou   la malignit  de la tumeur. Tout cela va conduire le chirurgien   faire la biopsie pour poser le diagnostic histologique. Le scanner ou l'angioscanner viennent apr s l'IRM, surtout en cas de suspicion de l sion vasculaire et lorsqu'on suspecte aussi une tumeur bien vascularis e.

(15:55 - 16:42)

Parfois, il permet de montrer l'existence de calcifications, mais   ce moment-l , l'apport de l'IRM pour faire le diagnostic, par exemple, de myosite ossifiante ou d'osteosarcome des tissus mous,

leur diagnostic sera fait par l'IRM. Donc, exceptionnellement quand on demande un scanner pour les tumeurs des tissus mous, à part s'il y a des lésions vasculaires. Et même à ce moment-là, l'angio-IRM permettra de poser le diagnostic de ces tumeurs vasculaires ou d'envahissement vasculaire lorsqu'il s'agit d'une tumeur des tissus mous.

(16:44 - 17:08)

D'autres éléments d'investigation concernant les tumeurs des tissus mous, notamment la scintigraphie, le scanner abdominal, voire le PET scan quand on suspect des localisations métastatiques ou parfois quand il y a des lésions multiples. Leur apport, bien sûr, sera en fonction de chaque tumeur. La troisième démarche diagnostique, c'est la biopsie.

(17:08 - 17:33)

Elle permet de préciser le diagnostic par l'étude histologique. Plusieurs types de biopsies sont réalisés, notamment la biopsie à l'aiguille, qui consiste à faire un prélèvement de tissu tumoral de 1 mm environ, mais il est responsable de 40 % d'erreurs. La biopsie au trocard est la plus utilisée actuellement et donne plus de 90 % de diagnostic positif.

(17:34 - 17:58)

Elle est utilisée par un trocard de 14 gorges, par le radiologue, soit écougaidé ou scanoguidé, pour mieux cibler la zone tumorale et éviter les zones nécrotiques. Elles ont beaucoup plus l'avantage de ne pas faire d'anesthésie. Le patient ne sera pas obligé d'être hospitalisé.

(17:59 - 18:48)

Il récupérera sa fonction le plus rapidement possible, donc il n'y a pas d'incision, il n'y a pas d'hémostase à faire et il n'y a pas de risque d'ensemencement de la cicatrice par les cellules tumorales. Quant à la biopsie chirurgicale, il y a certaines règles à respecter, notamment, elle doit être faite en concertation avec le chirurgien. Sinon, idéalement, elle sera faite par le chirurgien sur le trajet de l'incision de la chirurgie ultérieure, parce que l'incision de la biopsie, elle sera ensemencée par les cellules tumorales, donc il faudra l'enlever pour le deuxième geste chirurgical.

(18:49 - 19:39)

Il faut qu'il y ait une hémostase correcte et éviter de poser les redents, parce qu'ils sont aussi source d'ensemencement par les cellules tumorales. Dernière type de biopsie, c'est la biopsie exérèse, donc on enlève toute la tumeur, ainsi que son environnement, parce que la lésion est superficielle, sous-cutanée, de moins de 3 cm, elle est bien palpable et bien limitée, et loin d'éléments vasculonormaux. Alors, tous les prélèvements de la biopsie doivent être envoyés au même laboratoire et vus par le même anatomopathologiste.

(19:40 - 20:21)

Le banc doit être bien rempli avec des renseignements cliniques accompagnés d'une imagerie pour que l'anatomopathologiste puisse aussi avoir une idée sur les examens paracliniques ainsi que sur les renseignements cliniques. Le pathologiste ne va pas se limiter à établir le type et le type histologique de la tumeur, mais il va apporter également des éléments déterminants concernant le degré d'agressivité et le pronostic de la lésion. L'héméno-histochimie est aussi une technique essentielle dans la démarche diagnostique.

(20:22 - 20:47)

Elle va reposer sur le principe de la réaction antigène-anticorps. Elle permet de mettre en évidence plusieurs types d'antigènes potentiellement présents au niveau des cellules, et donc permet de terminer la lignée des différenciations cellulaires et d'aboutir à un diagnostic. Par exemple, les marqueurs de différenciation épithéliale, comme les cytokératines, ou de différenciation musculaire, comme l'axine musculaire lisse, ou vasculaire, comme le CD31.

(20:48 - 21:09)

Elle permet aussi d'évaluer le pronostic de la lésion en évaluant les marges d'exérès de sécurité. Le but du traitement, c'est l'exérès extratumoral avec des limites saines pour éviter la récurrence. Henneking a classé les différents types d'exérès à viser pronostic.

(21:10 - 21:36)

L'exérès intralésionnel, c'est un exérès de la tumeur sans sa pseudo-capsule. Pour les tumeurs bénignes, le problème ne se pose pas, alors que pour les tumeurs malignes, le risque de récurrence reste élevé. Le deuxième type d'exérès, c'est l'exérès marginal.

(21:37 - 22:03)

La tumeur est enlevée avec sa pseudo-capsule, mais sans qu'il y ait un marge de tissu sain périlésionnel réel enlevé. Sur le plan macroscopique, la tumeur a été élevée, mais sur le plan microscopique, il y a une persistance de cette tumeur. L'indication de la radiothérapie s'impose pour éviter les risques de récurrence.

(22:05 - 22:46)

L'exérès large, la tumeur est enlevée en blanc ainsi que sa pseudo-capsule dans le compartiment. On va enlever la pseudo-capsule ainsi que les écloisons dans son compartiment en passant en zone saine. Le risque de récurrence est moins que celui de l'exérès marginal, mais c'est un exérès qui est assez intéressant pour les tumeurs bénignes d'un grand détail, mais pour les tumeurs malignes, on risque d'avoir des récurrences.

(22:47 - 23:24)

Là, cette exérèse large préserve la fonction. Alors que pour l'exérèse radical, c'est un exérèse où le risque de récurrence est beaucoup plus faible, la tumeur est enlevée en blanc avec son compartiment, ses muscles, avec leurs insertions, leurs éclosions, etc. Alors, concernant les indications pour les tumeurs bénignes, l'exérèse doit être extra-capsulaire pour éviter la récurrence.

(23:25 - 23:42)

Certaines tumeurs bénignes ont certaines agressivités locales et là, l'exérèse doit être large. Concernant la tumeur maligne, l'exérèse doit être faite en monobloc. On ne doit pas voir la tumeur avec des marges saines qui doivent dépasser les 2 cm.

(23:42 - 24:14)

Sans effraction de la tumeur au risque d'entraîner un non-semencement des cellules tumorales au niveau du site opératoire. L'exérèse doit aussi emporter la cicatrice de la biopsie. Il faut en plus essayer de préserver la fonction du membre si bien on peut le faire.

(24:14 - 24:38)

Sinon, bien sûr, lorsque la tumeur va envahir certains éléments nobles, l'exérèse s'impose. Tout ceci doit être géré par une équipe multidisciplinaire, notamment les chirurgiens vasculaires. Lorsque la tumeur envahit un vaisseau, on va sacrifier un vaisseau tout en réalisant un plantage vasculaire pour sauver le membre.

(24:39 - 25:35)

Les plasticiens, donc, de couvrir le site opératoire par des lombos musculaires face au cutané ou autre, les oncologues, les radiothérapeutes, pour soit une chimiothérapie néoadjuvante pour réduire la masse tumorale avant la chirurgie. La radiothérapie utilise des rayons ou des particules à haute énergie visant le lit tumoral ainsi que ses marges pour détruire les cellules cancéreuses. Elle est administrée pour différentes raisons, notamment pour détruire les cellules tumorales qui restent après la chirurgie, donc les cellules microscopiques, surtout pour l'exérèse marginal, afin de réduire le risque de récurrence.

(25:38 - 26:20)

On utilise la radiothérapie soit en post-opératoire comme traitement adjuvant ou bien comme traitement néoadjuvant préopératoire pour réduire la taille de la tumeur avant la chirurgie. Néanmoins, elle peut entraîner certaines complications, notamment la necroscutanie, surtout pour la radiothérapie externe qui va traverser la peau pour arriver au niveau de la tumeur ainsi que les tissus sous-jacents. Donc elle va entraîner des necroscutanées, la fibrose, avec un grand risque de lésions secondaires au niveau surtout cutanée.

(26:22 - 27:00)

Concernant la curithérapie, elle se sert d'une substance radioactive appelée radioisotope qui va être placée directement dans la tumeur ou près de la tumeur ou bien on peut aussi la mettre dans la région où la tumeur existait avant la chirurgie. Donc la radiation va détruire les cellules cancéreuses au fil du temps. La curithérapie engendre habituellement moins d'effets secondaires et de complications à long terme que la radiothérapie externe.

(27:01 - 27:29)

Elle va permettre aussi d'éviter les récidives utilisées lorsque la résection est incomplète. Un autre volet du traitement des tumeurs, surtout les sarcomes des tissus mous, c'est la chimiothérapie. Donc elle a recours à des médicaments anticancéreux ou cytotoxiques pour détruire les cellules cancéreuses.

(27:31 - 27:57)

Elle a pour objectif de détruire les cellules tumorales en cas de résection intratumorale ou marginale, en particulier quand le risque de récurrence est élevé. C'est une chimiothérapie qui est utilisée en post-opératoire, ce qu'on appelle aussi la chimiothérapie adjuvante. Elle permet aussi de réduire la taille de la tumeur avant la chirurgie et la rendre ainsi plus facile à enlever.

(27:57 - 28:22)

C'est la chimiothérapie pré-opératoire ou chimiothérapie neo-adjuvante. Elle permet de contrôler aussi la croissance ainsi que le micro-métastase d'un sarcome des tissus mous de stade avancé. L'association chimiothérapie et radiothérapie avant la chirurgie va permettre une amélioration de la résécabilité.

(28:22 - 28:41)

Ça veut dire qu'elle va faciliter la chirurgie et donc l'exérèse tumorale. Elle va diminuer le risque de récurrence locale et ainsi augmente le pourcentage de la chirurgie conservatrice. Après la radiothérapie, il y a la thérapie ciblée.

(28:42 - 29:15)

La thérapie ciblée a recours à des traitements qui vont cibler des molécules spécifiques comme des protéines présentes à la surface ou à l'intérieur de la cellule cancéreuse. Ces molécules vont contribuer à l'envoi de signaux qui indiquent aux cellules de croître et de se diviser. En ciblant ces molécules, les médicaments vont interrompre la croissance et la propagation des cellules cancéreuses tout en limitant les dommages aux cellules normales.

(29:15 - 29:37)

Comme exemple, le traitement de thérapie ciblée c'est l'imatinib qui est un inhibiteur de la tyrosine kinase. Il cible de nombreuses protéines différentes dont la protéine KIT, cette protéine qui aide les cellules à croître et à se diviser. L'imatinib va inhiber cette protéine.

(29:39 - 30:10)

La thérapie ciblée a vu l'amélioration de la survie médiane des patients tout en ciblant la tumeur et évitant les effets secondaires de la chimiothérapie. Une autre approche c'est la perfusion isolée. Cette perfusion consiste en une perfusion de la chimiothérapie à haute dose au niveau d'un membre en utilisant un garrot.

(30:11 - 30:45)

Il y aura une circulation extracorporelle et elle va éviter que la chimiothérapie puisse diffuser dans l'ensemble du corps et elle va diminuer les risques d'effets secondaires. Elle va cibler la tumeur par une circulation extracorporelle et la chimiothérapie sera à haute dose pour pouvoir tuer le maximum de cellules tumorales. La démarche diagnostique devant toute suspicion de tumeur des tissemeaux de membres c'est les trois éléments diagnostiques.

(30:45 - 31:52)

C'est la clinique, l'imagerie soit sur l'échographie mais surtout sur l'IRM et la biopsie qui va poser le diagnostic. On est soit devant une tumeur bénigne et là la prise en charge c'est l'exérès soit marginale extra-capsulaire pour éviter le risque de récurrence soit on est devant une tumeur maligne et là on peut avoir plusieurs cas de figure tout dépendra du type du sarcome département et bien sûr de la taille et de la nature et le grade de différenciation de ces tumeurs. Donc l'exérès doit être radical et on va en concertation avec l'anatomopathologiste l'oncologue et le radiothérapeute pour voir est-ce que c'est une tumeur où une chimiothérapie une radiothérapie néoadjuvant peut être utilisée bien sûr avant la chirurgie et bien sûr après l'exérès radical on pourra éventuellement faire la chimiothérapie ou la radiothérapie adjuvante.

(31:54 - 43:05)

Le pronostic des tumeurs des thussomous dépend essentiellement de la nature histologique de ces tumeurs notamment les sarcomes. Les facteurs pronostiques dépendent essentiellement du retard diagnostique du type histologique ainsi que du grade donc plus la cellule est indifférenciée le grade est élevé plus elle est de mauvais pronostics la taille volumineuse elle est aussi un élément de mauvais pronostics parce que le risque c'est lors de l'exérès de laisser des cellules tumorales lorsque la tumeur elle se développe en extra compartimental essentiellement la qualité de l'exérès chirurgical surtout lorsqu'elle est tumorale ou marginale ainsi que l'existence aux diagnostics d'adénopathie voire de métastase Concernant les sarcomes des thussomous la mortalité à 5 ans est de 25 à 40% alors que les récurrences peuvent aller jusqu'à 30% les métastases sont de l'ordre de 20% Donc nous allons voir quelques tumeurs des thussomous

notamment les sarcomes des tissus mous. Voici un patient qui a été vu à un stade tardif donc tumeur ulcéroborsténante de la racine de la cuisse et donc le bilan d'extension n'a pas montré de métastase et là une résection tumorale donc c'est une résection marginale de la tumeur donc de propreté puisque là la récurrence est inéluctable et le patient a suivi des séances de chimiothérapie et de radiothérapie avec des surveillances régulières d'éventuelles récurrences locales. Une deuxième tumeur récidivant de la face postérieure de la cuisse donc on voit la cicatrice opératoire donc c'est aussi un sujet âgé qui présente un liposarcome avec un refoulement d'une aire sciatique la tumeur le refoulait elle était au contact sans l'envoyer donc on voit ici la résection aussi c'est une résection large avec en portant la cicatrice de la biopsie et de la chirurgie secondaire et voilà le patient suivra aussi des séances de chimiothérapie de radiothérapie pour éviter toute récurrence ultérieure. Là c'est l'aspect d'un fibrosarcome de la face postérieure de la cuisse qui a envoyé le nerf fibulaire commun et donc cette chirurgie a sacrifié le nerf fibulaire commun et la patiente s'est retrouvée avec une paralysie du sciatique poplite externe. Donc voici une tumeur maligne de la première commissure parce que c'est une tumeur qui est augmentée de volume l'aspect polyloqué et avec une inflammation au niveau de la face dorsale aspect infiltrant de la peau. Le bilan qui a été demandé c'est une IRM de la première commissure ainsi que de la main avec comme suspicion diagnostique c'est une tumeur à cellules géantes. Une biopsie a été réalisée et a montré un sarcome des parties molles. La confirmation du type de sarcome une immunohistochimie a été réalisée pour confirmer le diagnostic de rhabdomyosarcome. Une exérèse a été réalisée. Quoi qu'il y a eu des infiltrations. La tumeur arrivait au contact de l'os avec des infiltrations des pédicules ainsi que des nerfs et la récurrence était présente. Une chimiothérapie ainsi qu'une radiothérapie sont préconisées dans ce cas pour éviter les récurrences. Voici une tumeur bénigne dont j'ai tenu à préciser parce que ce sont des tumeurs qui passent le plus souvent inaperçues ou ce sont des tumeurs méconnues par les médecins généralistes. C'est pour ça que j'ai tenu à préciser et à montrer ce type de tumeur. Alors c'est une tumeur ce qu'on appelle les tumeurs glomiques. C'est une hypertrophie du globe neuro-myoartériel de cause inconnue. Le diagnostic malheureusement il est le plus souvent tardif et méconnu comme j'ai dit. Elle se voit chez les femmes d'âge moyen. Elle se caractérise par des douleurs paroxystiques spontanées qui évoluent depuis longtemps. Ça peut aller d'un an jusqu'à 12 ans. La douleur elle est localisée au niveau des extrémités des doigts notamment dans la région sous-unguiale. On peut aussi avoir d'autres localisations notamment au niveau des bras au niveau des mains, au niveau des cuisses, etc. La douleur elle est augmentée par la pression donc c'est une zone gâchette. Parfois elle est augmentée par le froid. Elle n'est pas améliorée par le traitement médical. C'est des patients. On ne fait pas le diagnostic parce qu'on n'est pas devant une tumeur palpable. Donc on va prescrire un médicament on va dire aux patients ça va passer. Mais la douleur, elle ne passe pas. Et là, les examens complémentaires peuvent jouer un rôle important notamment on peut demander une radiographie. Lorsque la tumeur évolue dans le temps elle va montrer une empreinte ou une encoche au niveau de la phalange. Sinon c'est l'IRM qui permet de poser le diagnostic en montrant une masse sous-unguiale hypervascularisée. Et bien sûr, le traitement c'est un traitement chirurgical c'est la résection en bloc de la tumeur.

colomique et la douleur disparaît juste après la chirurgie. Donc voici notre patiente. Elle présente une tumefaction de la face palmaire du quatrième doigt qui évolue depuis un an. C'est une tumeur qui est mobile, qui est molle, qui n'entraîne pas de compression ni vasculaire, ni neurologique, même si elle est sur le trajet des nerfs collatéral-médial-ératique radiale. Donc, le reste de l'examen est sans particularité. Devant ce type de tumeur, on pourra demander éventuellement une échographie. Pourquoi ? Parce que c'est un examen qui est disponible, qui n'est pas cher et donc il est à la portée. Il nécessite bien évidemment des radiologues entraînés dans la pathologie de l'appareil locomoteur et il pourrait éventuellement poser un certain nombre de diagnostics. Comme pour cette patiente, l'aspect disposé en chapelet faisait évoquer une tumeur nerveuse, mais sur le plan clinique, ce n'est pas la douleur de la tumeur nerveuse. Un deuxième diagnostic pour une tumeur bénigne. Mais devant toute suspicion de tumeur maligne, une IRM pourrait être demandée chez cette patiente. Donc, vu la bénignité de la tumeur, on s'est contenté de l'échographie et donc la prise en charge chirurgicale a consisté en une exérèse en bloc de la tumeur sans faire une biopsie superficielle qui est de moins de 3 cm et donc elle a un accès qui est facile, donc on peut faire l'exérèse totale de la tumeur. Voici la patiente après cicatrisation et la lymphate est revenue comme un lipome, comme tumeur bénigne des parties molles et donc c'est la surveillance chez cette patiente d'éventuels récidives, ça reste rare. La prise en charge des tumeurs, des parties molles nécessite une démarche diagnostique qui repose sur trois éléments : l'examen clinique, l'imagerie, notamment l'IRM et l'étude anatomopathologique pour confirmer les présomptions diagnostiques.

Donc il faut savoir qu'il y a des tumeurs bénignes, elles sont plus fréquentes, les tumeurs malignes, elles sont plus rares. Entre les chirurgiens, entre les radiologues, les anatomopathologistes, pour typer et pour donner les grades de la tumeur, pour pouvoir se concerter avec les radiologues et les oncologues pour faire soit une chimiothérapie néoadjuvante, ensuite la chirurgie qui doit viser à la conservation du membre et donc c'est aussi une radiovasculaire pour éventuellement faire des pontages, éviter l'amputation du membre et ensuite probable chimiothérapie ou radiothérapie adjuvante en post-opératoire. Lorsque l'exérèse n'est pas radicale, bien sûr, le rôle du médecin généraliste est important, donc c'est lui qui pose avant tout un geste, soit de biopsie ou autre, une concertation avec le chirurgien reste l'élément clé pour une bonne prise en charge de ces tumeurs là.